

18 - 05- La bilharziose uro-génitale - Pr. IHBIBANE

Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours sur la bilharziose urogénitale. Les objectifs de notre cours sont les suivants, reconnaître la bilharziose urogénitale devant des arguments épidémiologiques cliniques et paracliniques, citer les complications de la bilharziose urogénitale et savoir traiter la bilharziose urogénitale. La bilharziose ou la cystosomiase fut découverte en 1852 par un médecin allemand, c'est le Dr. Billard.

La bilharziose urogénitale ou la cystosomiase urogénitale est une maladie parasitaire qui est due à un verre plat, platellement, de la classe d'être hématode du genre cystosoma. Pour les gens pathogènes, c'est le cystosoma hématomien qui vit dans les plexus veineux périrectaux et périviscéraux. La source est strictement humaine, le produit virulence est le douce entre 18°C et 30°C, la transmission se fait par pénétration des cerquières par voie transcutanée.

Concernant la réceptivité, il n'y a pas d'immunité naturelle, l'immunité acquise peut-être par atteinte antérieure. Concernant les facteurs favorisants, c'est essentiellement la prévention exposée, le développement des ressources hydrauliques, tels les barrages hydrauliques. Concernant la répartition géographique, au niveau mondial, c'est une pathologie qui sévit essentiellement au niveau de l'Afrique, le delta du Nil, la zone intertropicale et le Maghreb.

Au niveau du Maroc, c'est une pathologie qui a été éradiquée depuis 2005, le dernier cas a été enregistré en 2004. Voici une cartographie qui vous montre la distribution géographique de la bilharziose. Pour le cycle de maturation des bilharzioses, voici un schéma qui vous résume le cycle de maturation de la bilharziose à partir de la pénétration transcutanée active des furcocercaires jusqu'à excrétion des œufs de bilharzi dans les selles et les urines du sujet infecté dans le milieu extérieur.

Pour la physiopathologie, après pénétration de cercaires, il y aura une réaction cutanée allergique immédiate mais inconstante, maturation des larves qui va aboutir à la ponte des œufs et au stade chronique, on aura une production permanente des œufs et leur élimination dans les voies excrétrices avec constitution d'un granulome et d'une réaction fibreuse. Sur le plan clinique, après pénétration des cercaires, quelques heures à 7 jours après la contamination, on aura l'apparition d'une éruption papilleuse, prurigineuse qui peut passer inaperçue. Au cours de la phase d'invasion, 2 à 12 semaines après, inconstamment, on peut observer une fièvre, des céphalées, des phénomènes allergiques tels une dyspnée asthmatiforme, une éruption urticarienne, présence de troubles digestifs, une hépatomégalie, rarement une encéphalopathie, avec présence d'une hyper-isomophilie constante sur l'annumération de la formule sanguine et importante.

C'est ce qu'on appelle la fièvre de safari. Au cours de la période d'état, 10 à 12 semaines après la contamination, on aura des signes urinaires, une hématurie, macroscopique terminale récidivante parfois microscopique, présence d'une protéinurie, présence de signes de cystite et des signes

de surinfection microbienne. A la cystoscopie, présence de lésions caractéristiques du bas du fœndt vésical avec de fines granulations, avec aspects de grains de saumoule, présence d'ulcérations, rarement des poulies billardiennes.

Les signes génitaux chez l'homme, on peut observer une orchiepédidymite, l'hémospermie, une prostatite chronique chez la femme, une annexite, une cervicite, la stérilité, la dystocie et possibilité d'une grossesse extra-utérine. Pour les complications, on peut observer une sclérose et un rétrécissement du bas urtère avec dilatation pilocalicielle, unie ou bilatérale, surinfection et insuffisance rénale, la calcification de la vessie et la cancérisation de la vessie. Voici un schéma qui résume l'atteinte des reins, des urtères et de la vessie.

Au niveau des reins, on peut voir une hydronephrose, une néphrite interstitiale et une insuffisance rénale. Au niveau des urtères, une sténose terminale, une dilatation fixe-jacente, une dissociation des tuniques et une atonie. Au niveau de la vessie, des granules, un adénopapillum, des scléroses et des calcifications.

Et dans les urines, on peut avoir une hématurie avec présence des oeufs de bilharzie. Sur le plan radiologique, l'UIV peut nous mettre en évidence une urétérohydronephrose bilatérale avec urtère atone, une hydronephrose gauche par urétérite segmentaire lambert. C'est l'image en boule du rein droit avec dilatation de l'urtère et urétérite segmentaire pelvienne.

Le rein droit muet, urétérohydronephrose gauche avec rétrécissement de l'urtère pelvienne. Une image qui montre l'état du rein et de l'urtère dans le cadre de la bilharziose. Pour le diagnostic positif, il est basé sur des éléments d'orientation qui sont le séjour en zone d'endémie, la présence d'une hyper-isomophilie à un stade précoce et l'aspect de la paroi visicale à la cystoscopie.

Les éléments de certitude sont la présence des oeufs de cystosoma hematobium dans le culot de centrifugation ou de sédimentation urinaire, les examens histologiques qui vont mettre en évidence la présence d'un granulon bilharzien centré bas à neuf et la sérologie ELISA mais qui n'est pas spécifique d'espèce. Voici des images des oeufs de bilharziose. Pour le traitement, il est basé sur un traitement médicamenteux qui est le Praziquantel, le biltricide qui n'est pas commercialisé au Maroc mais qui est disponible dans les structures de santé.

Ce sont des comprimés dosés à 600 mg avec des boîtes qui contiennent 4 comprimés. La posologie est de 40 mg par kilo à prendre avant le repas en une seule prise. Après le traitement, il faut un contrôle parasitologique, c'est-à-dire la recherche de bilharzi dans les urines pendant 3 jours, successifs après 3, 6 et 12 mois.

Si positif, il faut prendre une deuxième cure. Si négatif, ça signifie la guérison. La chirurgie pourra être indiquée dans certains cas tels dans la sclérose.